

INFILTRACIÓN EN CODO

Ana Peñalver Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Reverol, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar debemos considerar las articulaciones que participan en la movilización del codo:

- Humerorradial: flexo-extensión y prono-supinación
- Humerocubital: flexo-extensión
- Radiocubital superior: prono-supinación

INDICACIONES

Epicondilitis

Infiltraremos el epicóndilo lateral (prominencia ósea externa). El dolor a ese nivel es producido por entesitis de la inserción de los músculos epicondíleos (tanto grupo extensor como supinador) por sobrecarga funcional o microtraumatismos repetidos. También por capsulitis de la articulación radiohumeral, entesitis del ligamento radial colateral, periostitis epicondílea o bursitis del espacio subtendinoso del grupo muscular extensor.

Se diagnostica por dolor en la cara externa del codo, que puede irradiar a la cara dorsal del antebrazo hasta la mano. El dolor aparece con la presión sobre la inserción tendinosa en el epicóndilo y se exagera con la extensión de la muñeca o la supinación contrarresistencia.

Epitrocleitis

Infiltraremos la epitroclea o epicóndilo medial. Se produce inflamación de las inserciones de los músculos flexores de la muñeca en la epitroclea por sobrecarga funcional. El paciente presentará dolor a la presión sobre la inserción tendinosa en la cara interna del codo. También se exagera a la flexión de la muñeca o con la pronación contrarresistencia.

Bursitis olecraniana

Infiltraremos la bursa olecraniana (del tríceps braquial) que se encuentra inflamada, ya sea por causa traumática o acúmulo de microcristales. El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido extraído nos dará el diagnóstico.

El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido sinovial nos dará el diagnóstico.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Epicondilitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa o la camilla con el codo en flexión a 90°. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor a la palpación en las proximidades del epicóndilo y se debe dirigir perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo el líquido en abanico.



Epitrocleitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y el codo en semiflexión y en rotación externa. También se podrá realizar con el paciente en decúbito supino, codo flexionado a 90° y la mano por encima de la cabeza. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor obtenido por palpación en las proximidades de la epitroclea.



Tener especial precaución en no infiltrar el canal cubital en la cara posterior de la epitroclea. Advertir al paciente de la posibilidad de alteraciones sensitivas transitorias en el territorio del nervio cubital. La dirección de la aguja será perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo el líquido en abanico.

Bursitis olecraniana

El paciente deberá estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y con el codo en extensión (también lo puede hacer en flexión). El punto de entrada será en la cara posterior del codo, en la zona tumefacta sobre el olécranon.



Delimitaremos la bolsa palpándola y realizaremos punción casi de forma paralela al plano cutáneo y evacuaremos el contenido de la bursa, cambiaremos la jeringa (sin quitar la aguja) e infiltraremos corticoide. La dirección de la aguja debe de ser oblicua a 30º respecto del plano cutáneo en dirección al hombro. Las primeras 24-48 horas se debe colocar un vendaje compresivo.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

Material para la asepsia de la piel:

- Povidona yodada o alcohol 70º
- Guantes, gasas, paños y apósitos estériles Jeringa de 2cc y 5cc
- Aguja subcutánea 25G

Material para la recogida de muestras (si precisa):

- Tubo de hematología: recuento celular Tubo de bioquímica: glucosa
- Tubo heparinizado: examen de cristales Tubo estéril: cultivo y tinción gram
- Tubo heparinizado: examen de cristales Tubo estéril: cultivo y tinción gram
- Tubo estéril: cultivo y tinción gram

Fármacos

- **Anestésicos locales** (sin vasoconstrictor):
 - Mepivacaina HCl 1-2%: potencia menor, duración 100 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
 - Lidocaína 1%: potencia mayor, duración 40 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
- **Corticoides:**

Principio activo	Triamcinolona acetónido	Betametasona acetato y fosfato
Potencia (comparada con hidrocortisona = 1)	5	30
Nombre comercial	Trigon depot®	Celestone cronodose®
Presentación	40 mg/ml. Ampollas de 1 ml	3 mg acetato + 3 mg fosfato/ml. Ampollas de 2ml

- Epicondilitis:**

- Jeringa de 2cc
- Aguja subcutánea 25G
- Corticoide depot 1-1,5cc (en este caso mejor utilizar Parametasona, ya que la Triamcinolona, al ser de mayor potencia y ser infiltración superficial, puede provocar mayor atrofia tisular)
- Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente

- Epitrocleitis:**

- Jeringa de 2cc
- Aguja subcutánea 25G
- Corticoide depot 1cc
- Anestésico 0,5cc (Mepivacina HCl 2%) o equivalente

- Bursitis olecraniana:**

- Jeringa de 5cc (para evacuar)
- Aguja intramuscular 21G o 20G
- Jeringa de 1-2cc
- Corticoide depot 1cc
- Anestésico 0,5cc (Mepivacina HCl 2%) o equivalente

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de infiltraciones en atención primaria, Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat, 2007, pags 13 – 16 y 29 – 32
- AMF: Infiltraciones. Laura Navarro Massip, Irene Rivero Franco